OpenHIS信创版操作手册

信创版HIS集十大核心模块于一体，涵盖目录管理、基础数据配置、个性化设置、门诊/住院全流程管理、药房药库智能管控、精细化耗材管理、财务核算体系、医保合规对接及多维报表分析等功能模块，共计372项标准化功能。 系统深度适配民营及公立一二级医院业务场景，支持单体医院、集团化运营及区域医疗协同等多种部署模式，并通过国家信创认证体系，确保全栈技术自主可控。

核心功能

- 门诊收费
- 门诊医生站
- 门诊护士站
- 住院收费
- 住院医生站
- 住院护士站
- 医技工作
- 药房管理
- 财务管理
- 医保管理
- 库房管理
- 报表管理
- 目录管理
- 基础数据
- 个性化设置

第一篇 基础数据

1 基础数据在整体业务中的位置

基础数据不参与直接收费或诊疗，但决定了业务能否正常开展。建议上线顺序：

组织与人员：科室 → 岗位/医务人员 → 患者档案

住院床位：病区 → 病房 → 床位（住院登记、护士分床依赖）

收费基础：费用性质、号源类型（挂号依赖）

临床目录：诊断、药品、诊疗、耗材、频次（医嘱依赖）

执行配置：执行地点、医嘱绑定（护士执行/计费依赖）

库房基础：库房/药房、供应商（采购/出库/发药依赖）

病历基础：文书类型、模板、元数据（医生站病历依赖）

系统字典：`CodeSystem`、枚举、部位等（全局下拉依赖）

2 组织与人员

2.1 科室管理

菜单位置：基础数据 → 科室管理

页面类型：查询列表 + 编辑弹窗

操作步骤：

进入页面，系统自动加载科室列表。

顶部筛选：可按关键字、科室类别、科室类型、启用状态过滤，点「查询」。

新增：点工具栏「新增」→ 弹窗填写科室名称、编码、类别、类型、上级科室等 → 保存。

编辑：行内点「编辑」修改已有科室。

启用/停用：行内切换状态；停用后新业务不可选该科室。

【提示】科室是医生站选机构、挂号选科室、执行地点树的基础，应最先维护。

2.2 岗位管理（医务人员）

菜单位置：基础数据 → 岗位管理

页面类型：左用户列表 + 右详情（签名 + 岗位分配）

操作步骤：

左侧按关键字分页查询系统用户，点击一行选中。

右侧上半区「医务人员签名」：为已建档医务人员上传/保存签名图片。

右侧下半区「岗位分配」：在科室树下为用户分配岗位角色（adm_pr_assign）。

保存后，该用户可在对应科室开展业务（如医生接诊、审批等）。

【注意】若用户显示「未建档」，需先在医务人员主数据中完成建档后再维护签名与岗位。

2.3 患者管理

菜单位置：基础数据 → 患者管理

操作步骤：

顶部按关键字、姓名等条件查询患者列表。

新增：点「新增」→ 填写姓名、性别、出生日期、证件号、联系方式、婚姻状况、血型等 → 保存。

编辑：行内「编辑」修改档案。

删除：行内「删除」，需二次确认。

学籍信息（若系统开启）：行内「学籍信息」维护学生专属字段（教育程度、就读方式等）。

【提示】门诊挂号、住院登记都会检索患者档案；建议先建档再办理业务，避免重复录入。

2.4 病区 / 病房 / 床位

菜单位置：基础数据 → 病区病房床位

页面类型：机构下拉 + 树形卡片（病区→病房→床位）

操作步骤：

顶部选择机构（必选），页面加载该机构下全部病区及下属病房、床位。

新增病区：点「新增病区」→ 弹窗填写病区名称、编码等 → 保存。

在某病区卡片点「新增病房」→ 填写病房信息 → 保存。

在某病房行点「新增床位」→ 填写床号、床位属性 → 保存。

编辑/删除：对应卡片或行的「编辑」「删除」按钮。

【注意】层级关系：机构 → 病区 → 病房 → 床位。住院登记选病区、护士分床、入出转管理均依赖此数据。

3 收费与挂号基础

3.1 费用性质

菜单位置：基础数据 → 费用性质

查询列表，可按条件筛选。

新增/编辑费用性质（如自费、医保、公费等）。

启用/停用；门诊挂号、住院登记时「费用性质」下拉来自此处。

3.2 号源类型（挂号类型）

菜单位置：基础数据 → 号源类型

维护普通号、专家号等挂号类型及关联费用。

新增/编辑/启用/停用。

门诊挂号页「号源类型」下拉使用此配置。

4 临床目录

4.1 药品目录

菜单位置：基础数据 → 药品目录

页面类型：左侧分类树 + 右侧分页列表

左侧点击药品分类树节点，右侧列表按分类过滤。

顶部关键字等条件查询。

新增：点「新增」打开编辑弹窗（或跳转详情页），填写药品名称、规格、单位、分类、价格属性等。

编辑：行内「编辑」进入详情维护。

启用/停用：控制药品是否出现在医嘱开立下拉；停用后新业务不可选，历史保留。

4.2 耗材目录

菜单位置：基础数据 → 耗材目录

左侧耗材类型树筛选，右侧列表展示。

新增/编辑耗材定义。

支持单条删除、批量启用/批量停用。

【提示】耗材目录供医嘱开立、护士记账、库房出库等业务引用。

4.3 诊疗目录

菜单位置：基础数据 → 诊疗目录

左侧诊疗分类树 + 右侧列表。

新增/编辑诊疗项目（名称、分类、价格等）。

启用/停用控制是否可开立。

4.4 诊断目录

菜单位置：基础数据 → 诊断目录

按关键字、诊断来源等筛选。

新增/编辑：填写诊断编码、名称、医保编码、分类等。

批量启用/批量停用、单条删除。

【提示】医生站诊断录入、住院登记入院诊断均检索此目录。

4.5 频次管理

菜单位置：基础数据 → 频次管理

列表查询全部用药/执行频次。

新增/编辑：配置频次编码、名称、周期、次数等。

复制：以已有频次为模板快速新建（编码需重新填写）。

启用/停用：停用后新医嘱不可选该频次，历史医嘱仍可见。

【注意】频次不支持物理删除，仅支持停用。

4.6 执行地点

菜单位置：基础数据 → 执行地点

页面类型：左侧科室树 + 右侧可编辑表格

左侧选择执行科室（机构树）。

右侧表格展示该科室下诊疗项目的执行地点配置。

行内编辑：选择活动类别 → 联动诊疗项目 → 填写执行地点、时段、优先级等 → 保存。

可新增行、删除行。

【提示】门诊/住院医生开处置类医嘱时的「执行地点」下拉依赖此配置。

4.7 医嘱绑定

菜单位置：基础数据 → 医嘱绑定

用途：配置号源、用法、诊疗之间的绑定关系（如某用法绑定某诊疗/耗材）

进入页面加载绑定类型、来源、目标表等初始化选项。

表格行内编辑：选择绑定类型 → 来源项 → 目标表 → 目标项 → 保存。

支持新增行、删除行、批量保存。

5 库房与供应链基础

5.1 库房管理

菜单位置：基础数据 → 库房管理

列表展示全部库房/药房位置（formEnum 区分药库、药房等）。

新增：点「新增」→ 填写名称、类型、所属机构等 → 保存。

编辑：修改基本信息。

启用/停用：控制该库房是否参与库存业务。

删除：仅未被引用的库房可删，需确认。

【提示】库房管理配置完成后，才能做采购入库、出库、发药扣库等业务。

5.2 供应商管理

菜单位置：基础数据 → 供应商管理

按关键字、供应商类型筛选。

新增/编辑：供应商编号、名称、地址、电话、邮箱、类型等。

批量启用/批量停用、单条删除。

【提示】药库订货、采购入库时选择供应商。

6 病历模板

菜单位置：基础数据 → 病历模板

页面类型： 页：病历模板 / 元数据字段；模板页左侧文书类型 + 右侧列表

6.1 文书类型（左侧栏）

维护病历文书类型（如入院记录、病程记录等）。

新增/编辑/删除文书类型，控制是否启用。

点击某一文书类型，右侧模板列表自动按该类型筛选。

6.2 病历模板（主 ）

筛选：关键字、文书类型、适用范围、就诊类别、启用状态。

新增：空白新建模板，填写名称、编码、文书类型、适用范围、模板正文。

编辑：修改已有模板内容与属性。

查看：只读打开，可复制为新模板。

复制：基于已有模板快速创建（不调后端 copy 接口，前端预填）。

删除：二次确认后删除。

6.3 元数据字段（）

维护病历结构化元数据字段定义。

新增/编辑字段编码、名称、类型等，供模板与病历编辑器引用。

【提示】医生站「住院病历/门诊病历」 的模板树与编辑器内容来自此处配置。

7 系统字典

7.1 字典管理（`CodeSystem` / 枚举）

菜单位置：基础数据 → 字典管理

页面类型：左侧双 （`CodeSystem` / 枚举字典） + 右侧概念列表

`CodeSystem` 模式

左侧 选「`CodeSystem`」，点击某一字典系统。

右侧展示该系统下的 Concept 列表。

新增 `CodeSystem` 或 Concept，编辑编码、显示名、定义等。

枚举字典模式

左侧 选「枚举」，点击某一枚举名。

右侧维护枚举项（code / display）。

【提示】全局大量下拉框（性别、状态、类别等）依赖此模块，改动前请评估对在途业务的影响。

7.2 部位管理

菜单位置：基础数据 → 部位管理

树形展示检查/治疗等部位层次。

新增/编辑/删除部位节点。

【提示】检查申请、体部位相关医嘱可能引用。

8 基础数据维护建议

8.1 新院上线配置顺序

科室 → 岗位/人员 → 费用性质/号源 → 病区床位 → 诊断/药品/诊疗/耗材/频次 → 执行地点 → 库房/供应商 → 文书类型/病历模板 → 字典核对

8.2 日常变更注意

停用优于删除：目录类数据通常只停用，避免历史医嘱/费用无法回溯。

先配后启：新科室、新库房配置完成并启用后，再开放给业务岗位使用。

改价/改目录：药品、诊疗价格变更需与收费、医保政策同步评估。

病历模板：修改已启用模板前，确认在途未保存病历不受影响。

附录 A 基础数据功能清单汇总

\1. [组织人员] 科室管理 — 科室列表查询/筛选（系统管理员）

\2. [组织人员] 科室管理 — 新增/编辑科室（系统管理员）

\3. [组织人员] 科室管理 — 启用/停用科室（系统管理员）

\4. [组织人员] 岗位管理 — 用户列表查询（系统管理员）

\5. [组织人员] 岗位管理 — 医务人员签名维护（系统管理员）

\6. [组织人员] 岗位管理 — 岗位分配(`adm_pr_assign`)（系统管理员）

\7. [组织人员] 患者管理 — 患者分页查询（登记员/管理员）

\8. [组织人员] 患者管理 — 新增/编辑患者档案（登记员/管理员）

\9. [组织人员] 患者管理 — 删除患者（管理员）

\10. [组织人员] 患者管理 — 学籍信息维护（登记员/管理员）

\11. [组织人员] 病区病房床位 — 机构切换与病区树（管理员）

\12. [组织人员] 病区病房床位 — 新增/编辑/删除病区（管理员）

\13. [组织人员] 病区病房床位 — 新增/编辑/删除病房（管理员）

\14. [组织人员] 病区病房床位 — 新增/编辑/删除床位（管理员）

\15. [收费挂号] 费用性质 — 费用性质 CRUD（管理员）

\16. [收费挂号] 号源类型 — 挂号类型 CRUD（管理员）

\17. [临床目录] 药品目录 — 分类树筛选/分页查询（管理员）

\18. [临床目录] 药品目录 — 新增/编辑药品（管理员）

\19. [临床目录] 药品目录 — 启用/停用药品（管理员）

\20. [临床目录] 耗材目录 — 分类树筛选/分页查询（管理员）

\21. [临床目录] 耗材目录 — 新增/编辑/删除耗材（管理员）

\22. [临床目录] 耗材目录 — 批量启用/停用（管理员）

\23. [临床目录] 诊疗目录 — 分类筛选/分页查询（管理员）

\24. [临床目录] 诊疗目录 — 新增/编辑诊疗项目（管理员）

\25. [临床目录] 诊疗目录 — 启用/停用（管理员）

\26. [临床目录] 诊断目录 — 分类/来源筛选（管理员）

\27. [临床目录] 诊断目录 — 新增/编辑/删除诊断（管理员）

\28. [临床目录] 诊断目录 — 批量启用/停用（管理员）

\29. [临床目录] 频次管理 — 频次分页查询（管理员）

\30. [临床目录] 频次管理 — 新增/编辑/复制频次（管理员）

\31. [临床目录] 频次管理 — 启用/停用频次（管理员）

\32. [临床目录] 执行地点 — 按科室树维护执行地点（管理员）

\33. [临床目录] 执行地点 — 行内编辑保存/删除（管理员）

\34. [临床目录] 医嘱绑定 — 诊疗/用法/号源绑定维护（管理员）

\35. [临床目录] 医嘱绑定 — 行内编辑/批量保存（管理员）

\36. [库房供应链] 库房管理 — 库房/药房列表（库管/管理员）

\37. [库房供应链] 库房管理 — 新增/编辑库房（库管/管理员）

\38. [库房供应链] 库房管理 — 启用/停用/删除（库管/管理员）

\39. [库房供应链] 供应商管理 — 供应商分页查询（库管/管理员）

\40. [库房供应链] 供应商管理 — 新增/编辑/删除供应商（库管/管理员）

\41. [库房供应链] 供应商管理 — 批量启用/停用（库管/管理员）

\42. [病历模板] 病历模板 — 文书类型维护（管理员）

\43. [病历模板] 病历模板 — 模板列表/筛选/CRUD（管理员）

\44. [病历模板] 病历模板 — 模板复制/查看（管理员）

\45. [病历模板] 病历模板 — 元数据字段维护（管理员）

\46. [系统字典] 字典管理 — CodeSystem 维护（管理员）

\47. [系统字典] 字典管理 — Concept 概念维护（管理员）

\48. [系统字典] 字典管理 — 枚举字典维护（管理员）

\49. [系统字典] 部位管理 — 部位树 CRUD（管理员）

附录 B 基础数据与业务模块的依赖关系

基础数据	被哪些业务使用
科室管理	挂号选科室、医生站、执行地点、岗位分配
患者管理	门诊挂号、住院登记
病区床位	住院登记、护士分床、入出转
费用性质/号源	门诊挂号、住院登记
药品/诊疗/耗材目录	医生开嘱、护士记账、收费、发药
诊断目录	医生诊断、入院诊断
频次	医嘱开立
执行地点	处置类医嘱
库房/供应商	采购、入库、出库、盘点
病历模板	门诊/住院医生站病历
字典/部位	全局下拉、检查部位

第二篇 门诊 · 住院 · 库房业务

1 使用前准备

1.1 登录与权限

使用医院分配的账号登录系统，不同岗位看到不同菜单（挂号、收费、医生站、护士站、发药、库房等）。

收费、护士执行、库房审批等操作会记录当前登录人为操作员，请使用本人账号，勿共用。

若某按钮灰色不可点，通常是：未选中患者、患者状态不允许、或未选机构/科室。

1.2 机构与科室选择

门诊医生站、住院医生站等页面，必须先选择当前工作的机构/科室，否则左侧患者列表为空，并提示「请先选择科室」。

库房/药房单据需确认当前操作的是哪个库房或药房（在单据表头中选择）。

1.3 界面布局习惯

系统里几类常见布局，熟悉后操作会更快：

布局类型	典型页面	怎么用
三栏工作站	门诊收费、门诊发药、门诊护士站	左栏选患者 → 中栏看明细/操作 → 右栏辅助信息
护士站双栏	住院护士站	左栏约 22% 宽选患者 → 右栏切 做具体业务
单据工作站	药库出库、采购入库、盘点等	左栏选历史单据或新建 → 右栏填表头+明细 → 底部按钮保存/审批

2 门诊业务完整流程

门诊典型路径：患者到院 → 窗口挂号 → 医生看诊开医嘱 → 窗口收费 → 药房发药。若有注射、处置等项目，还需门诊护士站执行。

2.1 场景一：普通门诊全流程

参与角色

挂号员 → 门诊医生 → 收费员 → 药师（有处置时加：门诊护士）

第一步：窗口挂号（挂号员）

菜单位置：门诊 → 挂号

页面结构：左侧挂号表单 + 右侧当日/历史就诊记录

操作步骤：

在左侧顶部下拉框「搜索患者（姓名/病历号/证件号）」中检索并选中患者。选中后，姓名、性别、出生日期、年龄等会自动填入下方表单。若是新患者，也可直接在表单中手工填写。

填写挂号必填信息：

患者姓名、身份证号、性别

科室（选定后，医生下拉会自动刷新为该科室医生）

医生

费用性质

号源类型

核对无误后，点击底部蓝色按钮「确认挂号」。

系统会先做一次预结算，然后弹出核对窗口，标题大意是：请核对以下信息，确认后将按预结算金额发起收费。窗口里会显示患者信息、挂号科室/医生、费用明细和合计金额。

核对无误后在弹窗内确认支付（默认现金渠道）。

成功后：左侧表单自动清空，右侧「就诊记录」列表刷新，出现一条新的挂号记录。

【提示】若填写的信息不完整，系统会提示「请填写完整的挂号信息」，请按提示补全后再点确认挂号。

【提示】需要重来时，点顶部「清空」按钮，会重置表单和患者选择。

本步完成后：患者有一条「已挂号、待接诊」的门诊就诊记录，医生站待诊队列可见。

第二步：医生接诊与开医嘱（门诊医生）

菜单位置：门诊 → 医生站

操作步骤：

确认页面顶部已选择当前机构/科室。

左侧默认显示「待诊」队列，可按日期、关键字搜索患者。

在待诊列表中双击某患者。系统会调用接诊接口，该患者进入「在诊」列表，表示医生已开始接诊。

选中在诊患者后，建议按以下顺序操作：

切到「诊断录入」，检索并保存诊断（可修改、删除）。

切到「开立医嘱」。

点击工具栏「新增」，在弹出的编辑卡片中选择药品/诊疗/耗材，填写剂量、频次、给药途径、药房等，点卡片内「保存」。

多条医嘱编辑完成后，在下方列表勾选需要生效的医嘱，点击工具栏「签发」。只有签发后的医嘱才会进入下游收费、发药、护士执行等环节。

若误签，可勾选后点「撤回」。西药医嘱支持「并组」「拆组」。

【注意】切换患者或离开「住院病历」 时，若病历有未保存内容，系统会提示是否丢弃，请先保存或确认。

本步完成后：药品医嘱 → 门诊发药可见；诊疗/处置 → 门诊护士站可执行；费用 → 门诊收费待收列表可见。

第三步：门诊收费（收费员）

菜单位置：门诊 → 收费

操作步骤：

看左栏「待收费患者」：

用单选按钮切换「全部 / 待收费 / 已结算」（日常收费选「待收费」）。

设置日期范围、在搜索框输入「姓名/业务号」筛选。

点击某个患者卡片选中该次就诊。

中间区域会显示患者基本信息和「收费项目列表」。在表格中勾选要收取的费用行（已结算的行无法勾选）。表格下方会显示「已选 X 项，合计 ¥...」。

（可选）若该就诊需要整体切换医保/自费记账，可点「转医保」或「转自费」，确认后刷新列表。

点击「确认收费」。系统预结算后会弹出结算窗口，选择支付渠道后确认。

看到「收费成功」提示后，左侧队列和中间明细会自动刷新。

本步完成后：费用已结清，药房可发药，相关处置可执行。

第四步：门诊发药（药师）

菜单位置：药房 → 门诊发药

操作步骤：

左栏选择「待发药」（默认），设置日期范围（默认当天），可按姓名/排队号搜索。

点击患者卡片。

中间区域：

切换「西药 / 中药」 查看对应处方。

在顶部下拉框选择「调配药师」（必填，不选无法发药）。

若某行有多个库存批次可选，双击「发放库房」列，选择具体的库房×批号。

系统默认勾选可发的处方组，也可手动调整勾选。

需要录入药品追溯码时，点「追溯码扫描」。需要预览纸质样式时点「查看处方单」。

点击「批量发药」，在确认框「确认对所选处方执行保存配药并发药？」中点确定。

发药成功后，可在左栏切到「已发药」查看历史。

本步完成后：患者可以取药离开；库存相应扣减。

第五步：门诊护士执行（有注射/处置时）

菜单位置：门诊 → 护士站

操作步骤：

左栏选择当天日期，点击患者。

中间「诊疗执行单」加载可执行项目（通常默认已勾选）。

底部点「批量执行（N）」执行所选项目。

若要取消执行：在行内点「取消执行」——若只有一条记录会直接取消；若有多条则弹出窗口勾选后取消。

本步完成后：处置类医嘱执行完毕，流程闭环。

2.2 场景二：退号、退药、退费

退号（挂号员）

在挂号页右侧「就诊记录」中找到对应记录，执行退号。系统会先校验是否可退，通过后再退号退费。

退药（药师）

进入「药房 → 门诊退药」。

左栏选「待退药」 和日期，点击患者。

核对中栏退药明细后，点「确认退药」。

已退记录可在「已退药」 查看。

退费（收费员）

进入「门诊 → 退费」，界面与收费页类似。

左栏选患者，中栏按原支付单分组展示可退明细。

勾选拟退费用行，必要时对保留行做「转医保/转自费」。

打开退费确认窗，核对后确认退费。

2.3 门诊医生其他功能

入院申请：在医生站工具栏打开「入院申请」弹窗，填写入院科室、病区、主诊断等，提交后进入住院登记流程。

退费申请：医生可发起可退费用项申请，供收费窗口后续处理。

3 住院业务完整流程

住院典型路径：登记入院 → 收预交金 → 护士分床 → 医生开医嘱 → 护士校对/执行/记账 → 药房发药 → 护士办出院 → 窗口结算 → 护士清床。

3.1 场景：计划入院到出院结算

参与角色

住院登记员 → 收费员（预交金/结算）→ 护士 → 住院医生 → 药师

第一步：住院登记（登记员）

菜单位置：住院 → 住院登记

有两种常见入口：

路径 A——有医生入院申请：

在列表上方按姓名、身份证号、登记状态查询。

找到状态为待登记的行，点操作列「登记」。

弹窗会带入部分患者和入院信息（有申请时入院诊断可能只读）。

补全并核对以下关键项：

入院科室（必选）→ 选定后「入院病区」下拉会自动加载

入院诊断（必选）

费用性质、入院日期、入院类型、入院方式、患者病情

预交金额与支付方式（可在登记时收首笔预交金）

提交后提示「登记成功，住院号 `XXXXX`」。

路径 B——无档案直接登记：

点列表工具栏右侧「住院登记」打开空白弹窗。

检索或手工填写患者基本信息和入院信息，其余同上。

【提示】选入院科室后留意「床位数」提示，了解病区容量。

取消登记：列表行点「取消」，可填写取消原因后确认。

本步完成后：产生住院就诊记录，护士站患者列表可见。

第二步：收取预交金（收费员）

菜单位置：住院 → 预交金

左栏按入院日期、关键字筛选，点击患者卡片。

确认该患者状态允许收退预交金（不允许时会提示）。

右侧输入金额（可用 100/200/500 等快捷金额）和支付方式，点收取。

下方流水表会刷新显示本次记录。

退预交金：点「退预交金」，在弹窗填退款金额和渠道后确认。

本步完成后：患者账户有预交金余额，最终结算时用于抵扣。

第三步：护士入科分床（护士）

菜单位置：住院 → 护士站 → 「入出转管理」→ 子 「入」

分床有两种常用方式：

方式 1——拖拽分床：

在左侧患者列表找到待分床患者（无床号，或页面上方黄条提示待分床名单）。

将该患者卡片拖到右侧床位图的空床上。

弹出「入科选床」对话框，填写：

体征：身高、体重、体温、血压、脉搏等

住院医师、主治医师、主任医师、责任护士

患者病情、入科时间

可选勾选「打印腕带」

点确认（按钮文字可能是「确认分床」等），成功后床位图刷新，患者显示床号。

方式 2——双击患者卡片：同样打开入科选床弹窗，再选择目标床位。

换床/互换：从已占床患者或床位块发起拖拽，拖到目标床，浮层会显示换床预览，松手后确认即生效。

【注意】床位图上方提示：「待分床拖向空床需填写体征；换床、互换松手后确认即生效」。

本步完成后：患者正式入科占床，可进行医嘱校对和执行。

第四步：住院医生开医嘱（医生）

菜单位置：住院 → 医生站

左侧选择在院患者。

「诊断录入」保存诊断。

「开立医嘱」：新增 → 编辑保存 → 列表勾选 → 「签发」。

住院特有操作：

「停嘱」：停止长期医嘱

「撤回」：撤销已签发医嘱

出院医嘱：通过专用弹窗填写出院时间、出院方式等

本步完成后：医嘱进入护士「医嘱校对」队列。

第五步：医嘱校对（护士）

菜单位置：护士站 → 「医嘱校对」

左侧勾选一位或多位患者（支持多选）。

顶栏切换：未校对 / 已校对 / 已停止 / 已作废；可按全部/长期/临时筛选。

展开患者卡片，勾选医嘱行。

在「未校对」 下：点批量校对；若有问题点退回并填写退回原因。

【注意】单次批量操作上限 50 条。

本步完成后：医嘱变为已校对，进入执行环节。

第六步：医嘱执行（护士）

菜单位置：护士站 → 「医嘱执行」

左侧多选患者。

顶栏设置：

状态： 待执行 / 已执行 / 不执行 / 取消执行

长临筛选：全部 / 长期 / 临时

截止时间（默认当天结束）→ 点「查询」

在表格「预计执行时点」列勾选要操作的计划点（注意：勾选的是具体时点，不是整行医嘱）。

「待执行」：点「执行医嘱」确认；或点「不执行」登记不执行。

本步完成后：用药/处置按计划执行，关联计费和发药。

第七步：住院记账（护士）

菜单位置：护士站 → 「住院记账」

【注意】本 要求左侧只选 1 位患者；多选时按钮不可用并提示。

子功能 A——计价确认：

子 「计价确认」，选时间范围后点查询。

勾选待确认项，点「批量划价」。

子功能 B——直接划价 / 医嘱补费：

子 「医嘱记账」可查看已计价医嘱树和费用明细。

点「批量划价」打开大弹窗：

左侧：选「耗材」或「诊疗项目」，输入编码/名称查询，点击行加入

右侧：已选项目填数量；耗材需填「发放库房 ID」

点「确认划价」或「确认补费」

第八步：费用明细查询（护士/收费参考）

菜单位置：护士站 → 「费用明细」

左侧单选一名患者。

选今天/昨天或自定义日期范围。

切换「明细 / 汇总」查看费用和合计。

第九步：住院发药（药师）

菜单位置：药房 → 住院发药

流程与门诊发药基本相同，差异如下：

可按病区筛选队列；

患者信息含床号、住院号；

不支持改选库房批号（库存由后端决定）。

第十步：办理出院（护士）

菜单位置：护士站 → 入出转管理 → 子 「出」

【注意】必须从上方床位图点选待出院/待结算/已结算的占床患者。仅点左侧在院列表无法办理出院，页面会提示「请从上方床位图选择…」。

在床位图选中患者，下方出院面板显示患者摘要。

点「刷新待办」，查看两块信息：

待执行医嘱（含阻塞原因）

待发/待退药明细

患者为待出院/待结算状态 → 点「办理出院」并确认。

患者已结算、仍占床 → 点「清床离院」释放床位。

本步完成后：出院手续办结，床位可接待下一位患者。

第十一步：住院结算（收费员）

菜单位置：住院 → 住院结算

顶部下拉框「请输入住院号/姓名搜索患者」，搜索并选中。

页面加载后查看：

费用合计：住院总费用、个人自费、预交押金总额、应补/应退金额

页：费用大类明细、费用明细清单、医保结算信息、减免记录

右侧：历史结算记录

在「费用明细清单」 勾选待结算行（默认通常已勾选）。

页面底部选择支付方式：现金 / 微信 / 银行卡。

点「确认结算」。系统内部会先预结算再确认落账。

看到「住院结算成功」后，可在历史记录中点「明细」查看。

可用「刷新费用」更新最新费用；「医保校验」视环境是否接通。

本步完成后：住院费用结清；护士可对已结算患者执行清床。

3.2 住院护士站：患者选择规则速查

功能	左侧选择方式	要求
医嘱校对、医嘱执行	勾选	可多选
住院记账、费用明细	勾选	只能选 1 人
入出转-出院	床位图点击	不能仅靠左侧列表

3.3 住院全流程时序（培训用）

住院登记 → 预交金 → 护士分床 → 医生开嘱 → 护士校对 → 护士执行 → 护士记账/系统计费 → 住院发药 → 医生下出院嘱 → 护士办出院 → 收费员住院结算 → 护士清床

4 库房与药房业务

库房业务主线：药库订货 → 采购入库 → 药库出库至药房 → 药房入库 → 临床发药扣库。各类单据页面结构相同：左侧单据列表，右侧表头+明细，底部统一按钮组。

4.1 单据通用操作流程

无论订货单、入库单、出库单还是盘点单，都按同一套状态流转操作：

在侧栏按日期、关键字筛选，点击已有单据；或新建空白单据。

填写表头（库房/药房、对方单位、日期、关联请领单号等）。

在明细表添加行：选药品/物资、数量、单价、批号、效期等。

点底部按钮完成相应动作：

按钮	什么时候用
保存单据	保存当前草稿（新建单号在保存后生成）
保存并提交审批	一步完成保存和提交
提交审批	对已保存草稿提交审批

按钮	什么时候用
审批 / 驳回	审批人同意或驳回（驳回需填原因）
撤回	撤回已提交的单据
删除单据	仅「待审核」状态可删

4.2 药库订货

菜单位置：库房 → 药库订货单

新建订货单，选订货库房、供应商，录入明细。

保存并提交审批，审批通过后可用于后续采购入库参考。

4.3 采购入库

菜单位置：库房 → 采购入库

填入库库房、供应商、入库时间。

明细行需填：药品、采购数量、单价、批号、生产日期、有效期。

走保存→审批流程，同意后药库库存增加。

4.4 药库出库（调拨至药房）

菜单位置：库房 → 药库出库

填「出库源库房」和「调入药房」。

推荐：在表头填写「已同意的请领单号」，系统自动带入明细，核对数量后保存。

审批同意后，药库减库存，药房侧待入库。

4.5 药房入库

菜单位置：药房 → 药房入库

填「入库源药库」和「调入药房」。

可关联已同意请领单号带入明细。

审批同意后，药房库存增加，门诊/住院发药可扣减。

4.6 库存明细（现库查询）

菜单位置：库房 → 库存明细

按名称/编码/批号、效期剩余天数、品类、库存状态、零库存等条件查询。

查询后可看底部进价/售价合计。

勾选行可「停供」或「恢复供应」（会影响临床开药/发药）。

支持导出当前查询结果。

4.7 盘点

药库盘点：库房 → 药库盘点

药房盘点：药房 → 药房盘点

选盘点位置、录入账存/实存，保存并审批后调整库存账实。

5 常见问题与对账

现象	先查哪里	常见原因
医生开了药，发药看不到	发药队列 + 医嘱状态	医嘱未签发；或未校对/未执行；或费用/状态不满足
收费列表为空	门诊收费左栏筛选	选错（待收费/已结算）；日期范围不对
住院结算金额不对	结算页费用合计	预交金未收；有新费用未点刷新；部分行未勾选
办不了出院	入出转-出	未从床位图选人；有待执行医嘱或待发药阻塞
住院记账按钮灰	住院记账	左侧选了多个患者，需只选 1 人
医嘱执行失败	医嘱执行	刷新左侧患者列表；确认患者账户信息完整
库房审批按钮灰	单据底栏	当前单据状态不允许该操作

医生：接诊 → 录入诊断 → 开药并签发。

收费员：门诊收费确认结算。

药师：门诊发药批量发药。

住院线

登记员：住院登记并收预交金。

护士：入科分床 → 校对 → 执行医嘱。

医生：补充长期/临时医嘱并签发。

护士：办理出院；收费员：住院结算；护士：清床。

库房线演示一张出库单：关联请领单 → 带入明细 → 保存并提交审批。